

Mis Resúmenes

[Inicio](#)[Bioquímica](#)[Bromatología](#)[Educación Alimentaria](#)[Nutrición 2](#)[Nutrición 2](#)[Inicio](#) > [Nutrición 2](#) > [Nutrición y Prevención de Enfermedades](#)

Nutrición y Prevención de Enfermedades

Nutrición 2 — Tema 4

Introducción

Los organismos internacionales como la **OMS** y la **FAO** reconocen la epidemia creciente de enfermedades crónicas, que aqueja tanto a todos los países desarrollados y está relacionada con los cambios de los hábitos alimentarios y del modo de vida.

Los mecanismos que conducen a las enfermedades crónicas están más claros, y se ha comprobado que hay intervenciones que reducen el riesgo, todos ellos apuntan a aclarar la función del régimen alimentario en la prevención y el control de la morbilidad y la mortalidad prematura causadas por las enfermedades no transmisibles (ENT). También se han identificado algunos de los componentes alimentarios específicos que aumentan la probabilidad de aparición de esas enfermedades en los individuos y las intervenciones adecuadas para modificar su repercusión.

Cambios en hábitos alimentarios

Los rápidos cambios experimentados por los regímenes alimentarios y los modos de vida en respuesta a la industrialización, la urbanización, el desarrollo económico y la globalización de los mercados. Esto está teniendo grandes repercusiones en la salud y el estado nutricional de las poblaciones, se ha ampliado la disponibilidad de alimentos, éstos se han diversificado más y ha aumentado el acceso a los servicios, también hay que contabilizar repercusiones negativas significativas en forma de hábitos alimentarios inapropiados, disminución de la actividad física y otros factores que han llevado al incremento de las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.

Estas características se combinan con la disminución del gasto energético que conlleva un modo de vida sedentario: transporte motorizado, aparatos que ahorran trabajo en el hogar, disminución gradual de las tareas manuales físicamente exigentes en el trabajo, y dedicación preferente del tiempo de ocio a pasatiempos que no exigen esfuerzo físico. Estos cambios en los hábitos alimentarios y el modo de vida, han generado las **ENT crónicas** — incluidas la obesidad, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer — son causas cada vez más importantes de discapacidad y muerte prematura.

Se reconoce la influencia del régimen alimentario en la expresión de la vulnerabilidad genética a las ENT, la necesidad de realizar acciones interdisciplinarias para abordar la alimentación durante todo el ciclo vital humano, por ello la nutrición está pasando al primer plano como un determinante importante de enfermedades crónicas que puede ser modificado, y no cesa de crecer la evidencia científica en apoyo del criterio de que el tipo de dieta tiene una gran influencia, tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida.

La Carga de Enfermedades Crónicas

Lo que es más importante, los ajustes alimentarios no sólo influyen en la salud del momento sino que pueden determinar que un individuo padezca o no enfermedades tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes a lo largo de la vida.

Actividad física

Algunos aspectos pertinentes que es preciso subrayar son los siguientes:

- El gasto energético asociado a la actividad física es una parte importante de la ecuación de equilibrio energético que determina el peso corporal. La disminución del gasto calórico que conlleva la reducción de la actividad física es probablemente uno de los factores que más contribuyen a la epidemia mundial de sobrepeso y obesidad.
- La actividad física tiene gran influencia en la composición del cuerpo: en la cantidad de grasa, de músculo y de tejido óseo.
- La actividad física y los nutrientes comparten en gran medida las mismas vías metabólicas y pueden interactuar de diversas maneras que influyen en el riesgo y la

patogénesis de varias enfermedades crónicas.

- Se ha comprobado que el buen estado cardiovascular y la actividad física reducen significativamente los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud.

Enfermedades crónicas

La dieta y la nutrición son muy importantes para promover y mantener la buena salud a lo largo de toda la vida. Está bien establecida su función como factores determinantes de enfermedades no transmisibles crónicas, y eso los convierte en componentes fundamentales de las actividades de prevención. Esas enfermedades incluyen la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la osteoporosis y las enfermedades dentales.

El problema de las enfermedades crónicas está lejos de limitarse a las regiones desarrolladas del mundo. Contrariamente a creencias muy difundidas, los países en desarrollo sufren problemas cada vez más graves de salud pública generados por las enfermedades crónicas. Otro ejemplo destacado es la obesidad, que está convirtiéndose en un problema serio en todo el mundo, a pesar de lo extendido de la desnutrición. En algunos países la prevalencia de obesidad se ha duplicado o triplicado durante el último decenio.

Las enfermedades crónicas son en gran medida enfermedades prevenibles. Si bien pueden ser necesarias más investigaciones básicas sobre algunos aspectos de los mecanismos que relacionan la dieta y la salud, los datos científicos actualmente disponibles proporcionan una base suficientemente sólida y verosímil para justificar la adopción de medidas en este momento. Además del tratamiento médico apropiado para los ya afectados, se considera que el enfoque de salud pública de la prevención primaria es la acción más económica, asequible y sostenible para hacer frente a la epidemia de enfermedades crónicas.

Las dietas tradicionales, basadas en gran parte en alimentos de origen vegetal, han sido reemplazadas rápidamente por dietas con unos altos contenidos de grasa, muy energéticos y constituidos principalmente por alimentos de origen animal. No obstante, la alimentación, aunque fundamental para la prevención, es sólo uno de los factores de riesgo.

Criterios generales para un diálogo con la industria alimentaria

Los criterios generales para un diálogo con la industria alimentaria se resumen en lo siguiente: **menos grasas saturadas; más frutas y verduras; etiquetado eficiente de los**

alimentos; e incentivos para la comercialización y producción de alimentos más naturales.

La Doble Carga de la Malnutrición

La doble carga de la malnutrición, que representa la **coexistencia de la desnutrición y la sobrenutrición (sobrepeso y obesidad)** en un mismo país, comunidad o incluso en una misma persona.

Los problemas de malnutrición por déficit o exceso siguen siendo algunos de los problemas más devastadores que enfrentan la mayoría de las personas en condiciones de pobreza continúan dominando la salud de las naciones más pobres del mundo.

Consecuencias de la malnutrición

Las trágicas consecuencias de la malnutrición incluyen la muerte, discapacidades, retraso del desarrollo mental y físico y, como resultado, retraso del desarrollo socioeconómico nacional.

- La carencia de yodo es la principal causa única prevenible de lesión cerebral y retraso mental en todo el mundo, **anemia ferropénica**, carencia de vitamina A sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil prematura por enfermedades infecciosas.
- El retraso del crecimiento intrauterino, definido como un peso al nacer por debajo de 2.500 gramos, todavía afecta a recién nacidos e influye en el crecimiento, la supervivencia y la capacidad física y mental en la infancia.

Dicotomía de malnutrición

La dicotomía de malnutrición o doble carga (exceso y déficit); la desnutrición de los niños sobre la base del indicador de peso inferior a normal (el peso para la edad) puede entrañar una importante subestimación de la presencia de obesidad en las poblaciones, con alta prevalencia de retraso del crecimiento. El empleo de este indicador puede llevar a los programas de ayuda a alimentar a personas de peso aparentemente inferior al normal, con el resultado indeseable de un agravamiento adicional de la obesidad.

En familias pobres puede coexistir la desnutrición (déficit de peso) con el sobrepeso u obesidad, porque una dieta barata pero calórica puede llevar al exceso de peso a pesar de la carencia de micronutrientes. El **Retraso de Crecimiento Intrauterino (RCIU)** se define como un peso al nacer inferior a **2500 gramos** y es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta.

Enfoque Integrado de las Enfermedades Relacionadas con la Dieta y la Nutrición

Las causas fundamentales de la malnutrición son la **pobreza** y la **falta de equidad**. La eliminación de estas causas requiere acciones políticas y sociales de las cuales los programas nutricionales pueden ser sólo un aspecto. La oferta de alimentos suficientes, inocuos y variados no sólo previene las carencias nutricionales sino que también reduce el riesgo de contraer enfermedades crónicas. Es bien sabido que las carencias nutricionales aumentan el riesgo de sufrir enfermedades infecciosas comunes, en particular las de la niñez, y viceversa. Por consiguiente, existe complementariedad, en el relativo a los enfoques de salud pública y las encaminados a programas y políticas orientados a prevenir las enfermedades relacionadas con la dieta y con la nutrición. La mejor manera de reducir la doble carga de morbilidad es adoptar varias políticas y programas integrados siendo la clave para la prevención del déficit nutricional y las infecciones.

Pautas establecidas

Ya se han establecido pautas diseñadas para asignar igual prioridad a la prevención de las carencias nutricionales y las enfermedades crónicas, las normas alimentarias para la población dan prioridad a la prevención y el control de las carencias nutricionales, las enfermedades infecciosas relacionadas con los alimentos y las enfermedades crónicas.

Dieta, Nutrición y Prevención de las Enfermedades Crónicas a lo Largo del Ciclo Vital

La carga rápidamente creciente de enfermedades crónicas es un determinante clave de la salud pública mundial. La evidencia de que los riesgos de sufrir enfermedades crónicas empiezan en la vida fetal y persisten hasta la vejez es cada vez mayor. Por consiguiente, las enfermedades crónicas del adulto reflejan distintas exposiciones acumuladas durante toda la vida a entornos físicos y sociales perjudiciales. Por todas estas razones, la Consulta de Expertos adoptó un enfoque que abarca toda la vida y capta tanto el riesgo acumulado como las numerosas oportunidades de intervenir que ello permite. Por ello se han recomendado e identificado **cinco etapas**: el desarrollo fetal y el entorno materno, la lactancia, la niñez y la adolescencia, la vida adulta, el envejecimiento y la ancianidad.

Intervenciones a lo Largo de la Vida

Hay numerosos datos científicos que destacan la necesidad de aplicar un enfoque que abarque toda la vida a la prevención y el control de las enfermedades crónicas. Sin embargo, el panorama todavía no está completo, y la evidencia acumulada adolece a veces de incoherencias. A partir de la información disponible, es posible afirmar lo siguiente:

Datos científicos confirmados

- Los regímenes alimentarios insalubres, la inactividad física y el tabaquismo son comportamientos de riesgo confirmados de enfermedades crónicas.
- Está firmemente establecido que la hipertensión, la obesidad y las dislipidemias son factores de riesgo de cardiopatía coronaria, accidentes cerebrovasculares y diabetes.
- Los nutrientes y la actividad física influyen en la expresión génica y pueden definir la vulnerabilidad.
- Los principales factores de riesgo biológicos y comportamentales surgen y actúan en etapas tempranas de la vida y siguen teniendo efectos nocivos a lo largo de la misma.
- Los principales factores biológicos de riesgo pueden seguir afectando a la salud de la generación siguiente.
- Es importante asegurar un entorno nutricional posnatal suficiente y adecuado.
- Determinadas intervenciones son eficaces, pero deben extenderse más allá de los factores de riesgo individuales y prolongarse toda la vida.

Beneficios de por vida

Algunas intervenciones preventivas en etapas tempranas de la vida reportan beneficios de por vida.

- El mejoramiento de los regímenes alimentarios reducirá los riesgos de muerte y discapacidad asociados a las enfermedades crónicas.
- La prevención mediante la dieta y la actividad física es una estrategia complementaria que retrasa la progresión de las enfermedades crónicas existentes y disminuye la mortalidad y la carga de morbilidad provocadas por esas enfermedades.

Continuación: Factores de Riesgo e Intervenciones

Considerando todo ello, está claro que los factores de riesgo deben ser abordados a lo largo de todo el ciclo de vida, mejorar la calidad de vida de las personas, prevención de enfermedades en la población, pueden reducir el gasto sanitario. Para que las intervenciones tengan efectos duraderos en la prevalencia de los factores de riesgo y la salud de las sociedades, es esencial asimismo modificar el entorno en el que se desarrollan estas enfermedades. Los cambios en los hábitos alimentarios, la influencia de la publicidad, la globalización de las dietas y la reducción generalizada de la actividad física han agravado en general los factores de riesgo y, probablemente, también las enfermedades sufridas en consecuencia. Para invertir las tendencias actuales se requerirán de políticas de salud pública multidimensionales.

Una combinación de actividad física, diversidad de alimentos e interacción social amplia constituye probablemente el perfil del modo de vida más adecuado para optimizar la salud, con el resultado de una mayor longevidad y un envejecimiento sano, según algunos datos científicos muestran que es necesario tomar a lo largo de una semana al menos 20, y probablemente hasta 30, tipos de alimentos biológicamente distintos, con predominio de los alimentos de origen vegetal, y sobre la base de la disponibilidad de alimentos.

Por ello es necesario abordar el tema debe estar en relación con la identificación de los factores de riesgo en la edad adulta y tercera edad, e iniciar los cambios entre los 3 a 5 años de edad, disminuir la ingesta de bebidas azucaradas (en particular por los niños) y de alimentos ricos en calorías y pobres en micronutrientes, así como las actividades

encaminadas a frenar el consumo de cigarrillos y potenciar la actividad física, tendrán repercusiones en toda la sociedad. Tales cambios requieren la participación activa de las comunidades, los políticos, los sistemas de salud, los municipios, así como de las industrias de la alimentación y el tiempo de ocio que dispone el ser humano.

© 2026 Mis Resúmenes Académicos. Todos los derechos reservados.